

CAPÍTULO 13.9

SBOR secundario

PERFIL EUNACOM 2.01.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **Síndrome Bronquial Obstructivo Recurrente (SBOR)** es una de las condiciones respiratorias más frecuentes en la práctica pediátrica ambulatoria. Su importancia radica en que el reconocimiento de la recurrencia cambia radicalmente el enfoque terapéutico, pasando de un manejo sintomático agudo a un esquema de mantenimiento muy similar al del **Asma**.

Definición y Fisiopatología

El SBOR se define clásicamente por la presencia de **3 o más episodios** de obstrucción bronquial (SBO) durante los primeros dos años de vida. Algunos autores y guías locales sugieren que a partir del cuarto episodio el diagnóstico es indiscutible, pero para fines prácticos y de examen, 3 episodios marcan el inicio del manejo como recurrente.

NOTA CLÍNICA

A diferencia del **Asma**, donde la base es una inflamación eosinofílica mediada por alergia (Atopia), en el SBOR la causa principal es una **hiperreactividad bronquial post-viral**. - El evento centinela suele ser una infección por **Virus Respiratorio Sincicial (VRS)** que causa una **Bronquiolitis** inicial. - Tras esta infección, la vía aérea queda "sensibilizada" o hiperreactiva. - Los episodios subsiguientes son gatillados por otros virus (Rhinovirus, Parainfluenza, Adenovirus) que en un niño sano solo causarían un resfriado común, pero en el paciente con SBOR provocan crisis obstructivas.

Diagnóstico

El diagnóstico del SBOR es **estrictamente clínico**. No se requieren pruebas de función pulmonar (que son difíciles de realizar en lactantes) ni biomarcadores para confirmar la recurrencia.

- **Criterio principal:** Historia clínica de ≥ 3 episodios de sibilancias y/o espiración prolongada, objetivados por un médico.
- **Anamnesis:** Es fundamental preguntar por antecedentes de **Bronquiolitis** previa, frecuencia de los cuadros y respuesta a broncodilatadores.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Aunque el diagnóstico es clínico, a todo niño con SBOR se le debe solicitar una **Radiografía de Tórax**. El objetivo no es confirmar la obstrucción, sino **descartar causas secundarias** de sibilancias recurrentes (como malformaciones congénitas, cuerpos extraños o fibrosis quística) y evaluar posibles complicaciones.

Manejo Terapéutico

El pilar del tratamiento en el SBOR es el control de la inflamación de la vía aérea para reducir la frecuencia y severidad de las crisis. A diferencia del SBO agudo único, aquí los **corticoides inhalados** son la piedra angular.

1. Tratamiento de Rescate (Sintomático)

Se utiliza para el manejo de las crisis agudas. - **Salbutamol:** 2 puff cada 4-6 horas SOS (según síntomas). Se mantiene la técnica habitual con aerocámara.

2. Tratamiento de Mantenimiento (Controlador)

Es la gran diferencia con el manejo del lactante sibilante ocasional. - **Corticoides Inhalados (Fluticasona o Budesonida):** Se indican de forma diaria y constante. - **Dosis inicial/Crisis:** Generalmente se inicia con dosis moderadas-altas (ej. 2 puff cada 12 horas) mientras el niño está saliendo de una crisis o cursa con una infección respiratoria. - **Dosis de mantención:** Una vez estable y sin síntomas por varios días, se puede intentar reducir a una dosis mínima efectiva (ej. 1 puff al día o cada 12 horas según respuesta).

TABLA 13.9.1: MEDICAMENTO VS FUNCIÓN

MEDICAMENTO	FUNCIÓN	INDICACIÓN EN SBOR
Salbutamol	Broncodilatador de acción corta	Solo SOS en crisis (Rescate)
Corticoides Inhalados	Antiinflamatorio de vía aérea	Uso diario (Controlador)
Corticoides Sistémicos	Antiinflamatorio potente	Solo en crisis graves o manejo hospitalario
Montelukast	Antagonista de receptores de leucotrienos	Segunda línea (más útil si hay sospecha de atopia/ Asma)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En el SBO agudo (primer episodio), el uso de corticoides inhalados **no está indicado**. Su uso se reserva exclusivamente para el paciente que ya cumple criterios de **recurrencia** (SBOR). No confunda el corticoide inhalado de mantención con el corticoide sistémico (oral/EV) que se usa en crisis moderadas-severas.

Seguimiento y Consideraciones

- **Montelukast:** Si bien es una herramienta útil en el **Asma** infantil, en el SBOR post-viral puro su eficacia es menor. Sin embargo, puede considerarse si se sospecha un componente alérgico importante o como terapia adyuvante.
- **Evolución:** La mayoría de los cuadros de SBOR post-viral tienden a mejorar hacia los 3-5 años de edad a medida que el diámetro de la vía aérea aumenta y la hiperreactividad disminuye. Si los síntomas persisten más allá de esa edad, se debe reevaluar el diagnóstico hacia **Asma** bronquial.
- **Educación:** Es vital instruir a los padres en la técnica de inhalación con aerocámara, ya que el fracaso del tratamiento suele deberse a una mala técnica.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda: 1. **SBOR = 3 o más episodios**. 2. **Diagnóstico = Clínico**. 3. **Rx Tórax = Para descartar otras patologías**. 4. **Tratamiento = Corticoides inhalados permanentes**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Lactante de 14 meses con SBOR que presenta dos neumonías por *Pseudomonas aeruginosa*, diarrea crónica con deposiciones grasas y desnutrición. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para SBOR secundario. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Cuatro causas de SBOR secundario: cardiopatías congénitas, fibrosis quística, disquinesia ciliar y displasia broncopulmonar
- Cardiopatías: soplo holosistólico (CIV), en maquinaria (DAP), mesosistólico eyectivo (CIA); diagnóstico con ecocardiograma
- DAP se cierra con AINEs (ibuprofeno, indometacina); prostaglandinas lo mantienen abierto en cianóticas
- Fibrosis quística: bronquiectasias, neumonías por *Pseudomonas/Staphylococcus*, malabsorción intestinal
- Test del sudor: cloro >60 confirma, 30-60 indeterminado (pedir genético), <30 descarta fibrosis quística
- Enfermedad de cilios inmóviles: igual que FQ sin diarrea, con rinitis/otitis recurrente y dextrocardia en ~50%
- Síndrome de Kartagener = disquinesia ciliar + dextrocardia/situs inversus
- Displasia broncopulmonar: O2 >36 semanas EG + antecedente de membrana hialina; complicación = hipertensión pulmonar
- Sildenafil se usa en hipertensión pulmonar severa en displasia broncopulmonar

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SBOR SECUNDARIO)**PREGUNTA 1**

Lactante de 14 meses con SBOR que presenta dos neumonías por *Pseudomonas aeruginosa*, diarrea crónica con deposiciones grasas y desnutrición. ¿Cuál es el examen más adecuado para confirmar la sospecha diagnóstica?

- A)** Ecocardiograma
- B)** Óxido nítrico nasal
- C)** Test del sudor
- D)** Biopsia de epitelio nasal
- E)** TAC de tórax

PREGUNTA 2

Niño de 3 años con bronquiectasias bilaterales, neumonías recurrentes por *Pseudomonas*, rinosinusitis crónica, otitis media a repetición y dextrocardia en la radiografía de tórax. El test del sudor muestra cloro de 15 mEq/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Fibrosis quística
- B)** Displasia broncopulmonar
- C)** Síndrome de Kartagener (disquinesia ciliar primaria)
- D)** Cardiopatía congénita con dextrocardia
- E)** Inmunodeficiencia primaria

PREGUNTA 3

Recién nacido de 28 semanas que cursó con enfermedad de membrana hialina al nacer. Actualmente tiene 37 semanas de edad gestacional corregida y sigue requiriendo oxígeno suplementario. ¿Cuál es el diagnóstico y la complicación más importante a buscar?

- A)** Displasia broncopulmonar; buscar hipertensión pulmonar con ecocardiograma
- B)** Fibrosis quística; confirmar con test del sudor
- C)** Membrana hialina persistente; buscar déficit de surfactante
- D)** Cardiopatía congénita; buscar comunicación interventricular
- E)** Neumonía neonatal; iniciar antibióticos de amplio espectro

RESUMEN: SBOR SECUNDARIO

El SBOR secundario agrupa las causas no virales que pueden producir un síndrome bronquial obstructivo recurrente en lactantes y niños. Las cuatro causas principales son: cardiopatías congénitas, fibrosis quística, enfermedad de cilios inmóviles (disquinesia ciliar) y displasia broncopulmonar. Cada una tiene elementos clínicos y radiológicos orientadores específicos. Las cardiopatías congénitas se sospechan ante soplos cardíacos: soplo holosistólico (CIV), soplo en maquinaria o sistodiastólico continuo (DAP), o soplo mesosistólico eyectivo (CIA). La cardiomegalia en la radiografía también orienta, con dilatación derecha en la CIA e izquierda en la CIV y el DAP. El diagnóstico se confirma con ecocardiograma y el tratamiento es quirúrgico, pudiendo usarse AINEs (ibuprofeno, indometacina) para cerrar el DAP. Las prostaglandinas, por el contrario, mantienen abierto el ductus en cardiopatías cianóticas ducto-dependientes. La fibrosis quística se sospecha ante bronquiectasias, neumonías por *Pseudomonas* o *Staphylococcus aureus*, y síndrome de malabsorción intestinal por déficit de páncreas exocrino. Se diagnostica con test del sudor (cloro >60 mEq confirma; 30-60 es indeterminado y requiere test genético; <30 descarta). El manejo incluye soporte, antibióticos que cubran *Pseudomonas*, azitromicina profiláctica y trasplante pulmonar como última línea. La enfermedad de cilios inmóviles presenta clínica respiratoria similar a la fibrosis quística (bronquiectasias, neumonías por *Pseudomonas* y *Staphylococcus*) pero sin diarrea, y con rinitis, rinosinusitis y otitis media aguda recurrente. En el 50% de los casos hay dextrocardia o situs inversus (síndrome de Kartagener). Se estudia con óxido nítrico nasal (bajo en disquinesias) y se confirma con biopsia de epitelio nasal o bronquial. La displasia broncopulmonar se define como requerimiento de oxígeno más allá de las 36 semanas de edad gestacional en un prematuro con antecedente de enfermedad de membrana hialina. Se estudia con ecocardiograma buscando hipertensión pulmonar, su complicación más clásica, que puede tratarse con sildenafil.